Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Email: fruruguaia2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012086-10.2021.8.21.0037/RS

AUTOR: ANTONIO LOURENCO COPETTI
ADVOGADO(A): ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA (DPE)

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

ANTÔNIO LOURENÇO COPETTI ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** ambos qualificados na inicial (evento 1, INIC1). Narrou que sofre de câncer de próstata (CID10 C61), com indicação de terapia sistêmica não cirúrgica, necessitando fazer uso do medicamento *acetato de abiraterona 250mg,* via oral, 04 comprimidos ao dia. Disse que teve indeferido pedido administrativo de concessão do fármaco e que a não utilização agravará seu quadro de saúde, podendo levá-lo a morte. Aduziu que o custo mensal do tratamento atinge a quantia de R$ 14.858,86. Afirmou não dispor, no entanto, de recursos para aquisição do fármaco. Sustentou que o direito à vida é garantia constitucional, e que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Discorreu sobre o direito, colacionando legislação e citando decisões de Tribunais Superiores. Postulou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Estado que providenciasse o fornecimento do medicamento que necessita, qual seja, *acetato de abiraterona 250mg,* na quantidade de uma caixa com 120 comprimidos por mês, ou o custeio junto à rede particular. Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o demandado ao fornecimento do medicamento ou seu custeio junto a rede particular. Pugnou pela concessão do benefício de gratuidade de justiça e acostou documentos no E1.

Deferiu-se gratuidade de justiça ao autor, assim como o pedido de tutela de urgência (evento 9, DESPADEC1).

Expediu-se e-mail de cientificação da decisão (evento 12, EMAIL1).

Citado (E13), o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 14, CONT1). Inicialmente, dissertou sobre o descabimento de aplicação de multa diária e necessidade de observância aos temas fixados pelos Tribunais Superiores na área da saúde. Alegou a necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS, conforme tese firmada no Tema 793 do STF. Afirmou que não compete ao gestor estadual o financiamento, definição de diretrizes e execução da política oncológica, que são de responsabilidade da UNIÃO. Discorreu sobre a política nacional de prevenção e controle do câncer, citando legislação atinente ao tema. Falou sobre o tratamento oncológico fornecido pelo SUS, defendendo a obrigatoriedade de que o primeiro atendimento seja realizado dentro da rede pública de saúde. Discorreu, ainda, acerca dos centros de referência para tratamento oncológico (CACON ou UNACON) e forma de atuação. Falou sobre os ônus sucumbenciais. Requereu o acolhimento da arguição de necessidade de cumprimento do Tema 793 do STF, com a determinação de emenda da inicial para que seja incluída a UNIÃO no polo passivo e, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal. Requereu, ainda, a improcedência da ação e formulou pedidos de dilação probatória. Juntou documentos.

Em réplica (evento 17, RÉPLICA1), o demandante refutou as alegações do ESTADO e defendeu a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o fornecimento de medicamentos. Discorreu sobre a fixação de honorários ao FADEP.

Intimados sobre o interesse na produção de provas (decisão do evento 19, DESPADEC1), o autor silenciou (E25), enquanto o réu manifestou-se no evento 23, PET1, reiterando as provas postuladas em contestação, consistentes na remessa dos autos ao DMJ para manifestação acerca da necessidade, da adequação e da eficácia do(s) medicamento(s)/insumo(s) postulado(s), em comparação com a alternativa referida no Parecer Técnico da SES/RS pelo Sistema Único de Saúde e, ainda, para que a parte autora comprovasse a existência da enfermidade, a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento pleiteado, bem como a impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para tratamento da moléstia apresentada e, ainda, que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento das provas pretendidas pelo ESTADO (evento 31, PROMOÇÃO1).

Indeferiu-se o pedido de remessa dos autos ao DMJ (evento 33, DESPADEC1).

Intimados, o autor silenciou (E41), o ESTADO manifestou ciência (evento 38, PET1), assim como o Ministério Público (evento 40, PROMOÇÃO1).

O Ministério Público exarou parecer final pela procedência da ação (evento 48, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, impositivo registrar a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, julgou o Incidente de Assunção de Competência nº 14, fixando a seguinte tese jurídica:

> *a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.*
>
> *b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.*
>
> *c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).*

Ainda, em 17 de abril de 2023, em decisão monocrática, o Relator do **TEMA 1234**, Ministro Gilmar Mendes, prolatou decisão assim ementada:

> ***EMENTA:*** *TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.*
>
> *1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.*
>
> *2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.*
>
> *3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.*
>
> *4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.*
>
> *5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:* ***5.1.*** *nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;* ***5.2.*** *nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;* ***5.3.*** *diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos* ***sem sentença prolatada****; diferentemente, os processos* ***com sentença prolatada até a data desta decisão*** ***(17 de abril de 2023)*** *devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos* ***Tema*** *992, de minha relatoria, DJe de5.2.2021);* ***5.4.*** *ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.*

Em 19/4/2023, o Tribunal Pleno do STF, referendou a decisão liminar proferida em 17/04/2023 no RE 1366243 (**TEMA 1234**), pelo relator Ministro Gilmar Mendes, concedendo parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

> ***(i)*** *nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> ***(ii)*** *nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
>
> ***(iii)*** *diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> ***(iv)*** *ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.*

Assim, por meio das referidas decisões, as quais são vinculantes a todos os juízes e Tribunais, nos termos do art. 927, III e do art. 947, § 3º, do Código de Processo Civil, restam estabelecidas as diretrizes a serem observadas na fixação da competência e da legitimidade passiva em ações de fornecimento de tecnologias de saúde.

No caso dos autos, tem-se que o fármaco objeto da lide, *acetato de abiraterona 250mg,* apesar de ter registro na **ANVISA**, não é incorporado na lista pelo SUS, de modo que não integra a lista do **RENAME**, algo que, em tese, resultaria na necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da lide (questão objeto do TEMA 1234, inclusive).

Entretanto, considerando o acima exposto, devem os autos permanecer perante este juízo, pelo menos, até o julgamento final do **TEMA 1234**, em atenção ao estabelecido no item ii acima referido, no sentido de que, *nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.*

Feitos tais esclarecimentos, parto ao exame do feito.

Trata-se de ação através da qual o requerente pretende o fornecimento do fármaco *acetato de abiraterona 250mg,* necessário ao tratamento da doença que lhe acomete (câncer de próstata – CID C61).

A obrigação no fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre, conforme já mencionado, da Constituição Federal.

Sabidamente, o constituinte garantiu de forma expressa no art. 196 "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Outrossim, destaca-se, implícito no art. 5°, *caput*, o direito à vida, bem como estabeleceu em seu artigo 6° o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental, não sendo lícita a supressão dos aludidos direitos, face à proibição de retrocesso.

Ora, a negativa de fornecimento dos medicamentos necessários à saúde e à vida da paciente sem condições econômicas de adquiri-los configura, por si só, supressão de direito fundamental à saúde. Assim, não ocorre qualquer violação à independência do Poder Executivo, na medida em que não se está dispondo acerca de matéria orçamentária na sentença, tão-somente evitando-se a supressão de garantia fundamental.

Ainda, rechaço a alegação de legitimidade exclusiva da União para fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de neoplasia (câncer), uma vez que o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que há solidariedade entre os entes federados, havendo, apenas, a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, exceto na hipótese de "(...) ***a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)"***, em que "***a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação"***, conforme assentou Ministro Fachin ao concluir seu voto nos embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário 855.178/SE:

> *Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:* ***i)*** *A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);* ***ii)*** *Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;* ***iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v)*** ***Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;*** *vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.*

Ademais, a questão está, também, abarcada pelo **TEMA 1234**, conforme acima esclarecido.

Dito isso, na hipótese dos autos, a parte demandante acostou laudos médicos ao evento 1, ATESTMED8 e evento 1, LAUDO9, p. 01, que demonstram a moléstia que a acomete (câncer de próstata – CID C61), bem como receita médica (evento 1, LAUDO9, p. 02), com prescrição, pela médica que a examinou e acompanha a evolução da doença, do medicamento pleiteado.

Da mesma forma, a negativa do Estado no fornecimento do fármaco além de constituir fato público e notório, restou demonstrada através do documento juntado no evento 1, OUT10.

Em acréscimo, evidencia-se, considerando que se trata de pessoa representada pela Defensoria Pública, bem como considerando a declaração acostada no evento 1, DECLPOBRE2, tem-se que demonstrada situação a lhe conferir hipossuficiência financeira à aquisição das medicações.

Demais disso, cumpre ressaltar-se a presença, no caso dos autos, dos requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme REsp 1.657.156 – RJ, recurso representativo de controvérsia (**TEMA 106 STJ**), tal qual já mencionado na decisão do evento 33, DESPADEC1, a saber:

> *I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *(III) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Portanto, impõe-se a procedência da demanda, para que seja o requerido compelido a fornecer à parte autora os medicamentos postulados, tornando-se definitiva a liminar deferida e demais decisões que deferiram as substituições e inclusões dos medicamentos no decorrer da lide.

Portanto, impõe-se o julgamento de procedência do pedido, com a confirmação da liminar, para que o demandado forneça à parte autora o tratamento postulado.

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, recentemente, no julgamento do **TEMA 1002**, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento e fixou as seguintes teses vinculantes:

> *"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra **qualquer ente público, inclusive aquele que integra;** 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (grifei)*

Cabe ressaltar que, no corpo do seu voto, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso destacou a superação da Súmula 421 do STJ, nos seguintes termos:

> *"(...) 36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, **não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.***
>
> *37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo **perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)**." (Grifei)*

Por tais motivos, <u>cabível</u> a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido, ainda:

> ***Ementa:** APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. IDOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE ESTADUAL À DEFENSORIA PÚBLICA (FADEP) QUE O INTEGRA. TEMA Nº 1.002 DO STF. APLICABILIDADE. - O Tema nº 1.002 do STF fixou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE, EM GERAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE DO ITEM "II" ALÍNEA "A". FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO DO STJ. - Em se tratando de ação em que se discute Direito à Saúde, em geral, aplica-se o disposto no item "ii" alínea "a" do Tema nº 1.076 do STJ, o qual determinação a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Entendimento do próprio STJ em julgados posteriores à publicação do Tema supracitado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50017841820198210157, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-01-2024)*
>
> ***Ementa:** APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA (AO FADEP). POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Cabível a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (ao FADEP), em atenção ao entendimento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ (TEMA 1002), em sede de repercussão geral, que assentou o seguinte entendimento: "1. é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 2. Recurso de apelação da Defensoria Pública provido para condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários ao FADEP. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50897445320238210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 18-12-2023)*

No tocante ao arbitramento dos honorários, considerando que se trata de ação que envolve direito à saúde, matéria cuja natureza não é de grande complexidade, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (**TEMA 1076**), firmou a seguinte tese:

> *i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.*
>
> *ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.*

Com efeito, no caso em apreço, considerando o alto valor atribuído à causa e sua baixa complexidade, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, devendo esta ser feita de forma equitativa porquanto inestimável o proveito econômico da demanda, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, o fornecimento de tratamento médico e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

Pelo exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por **ANTONIO LOURENCO COPETTI** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar ao requerido que forneça ao requerente o fármaco *acetato de abiraterona 250mg,* nas medidas em que necessita a parte autora, ou providencie a liberação do valor correspondente. Tal obrigação fica condicionada à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada 4 meses. Eventual descumprimento acarretará o bloqueio das quantias correspondentes.

Isento o ESTADO do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Por outro lado, conforme fundamentação supra, condeno o ESTADO ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00 ao FADEP, ora fixados levando em conta os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2°e 8° do Código de Processo Civil. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir da presente decisão e, com o trânsito em julgado, acrescido unicamente de juros de mora pela taxa *selic.*

Publicação e registro eletrônicos. Agendada a intimação das partes pelo sistema.

Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, no prazo legal, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

A seguir, ao Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, cumpridas as determinações finais da sentença passíveis de cumprimento *ex officio* e, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **KARINA DE OLIVEIRA LEONETTI PADILHA, Juíza de Direito**, em 25/1/2024, às 15:0:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10039118032v19** e o código CRC **1c66e8a8**.